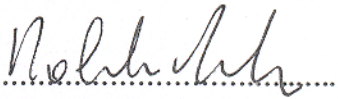
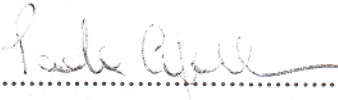


|                                                                      |                                                                                            |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Az. Osp. – Univ.<br/>Pisana</b><br><br>U.O. Medicina<br>d'Urgenza | <b>ASSISTENZA INFERMIERISTICA<br/>AL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE<br/>NON TRAUMATICO</b> | <b>P.O. 04</b><br><br>Rev. 0<br><br>Pag. 1 di 8 |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

**P.O. 04**  
**ASSISTENZA INFERMIERISTICA**  
**AL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE**  
**NON TRAUMATICO**

| Revisione | Data         | Approvato da   | Firma                                                                                 |
|-----------|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 0         | 26 OTT. 2007 | DIRETTORE U.O. |  |
|           |              | CAPOSALA       |  |
|           |              |                |                                                                                       |

ASSICURAZIONE QUALITA'  
E ACCREDITAMENTO  
COPIA VERIFICATA

**Il presente protocollo operativo è stata elaborato a cura di un gruppo di infermieri ed OSS operanti nella U.O. Medicina d’Urgenza:**

- *Del Frate Lucia* infermiera
- *Lonia Giovanna* infermiera
- *Roffi Sara* infermiera
- *Fabbrini Giovanni* OSS

e successivamente condivisa da tutto il personale medico, infermieristico ed OSS operante nella U.O. Medicina d’Urgenza.

**L’U.O.P. Formazione Permanente e Complementare del Personale Infermieristico** ha provveduto ad effettuare la verifica e la conformità rispetto a quanto previsto dagli specifici profili di competenza.

**La Sez. Int. Assicurazione Qualità, in ottemperanza alla P.A. 01: “Gestione documentazione qualità”, ha provveduto ad effettuare:**

- la verifica di conformità (requisiti attesi, codifica, congruità con la documentazione aziendale esistente);
- la convalida e l’emissione (responsabilità, approvazione, definizione lista di distribuzione);
- la distribuzione e la conservazione.

|                                                                              |                                                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Az. Osp. – Univ.<br/>Pisana</b><br><br><b>U.O. Medicina<br/>d’Urgenza</b> | <b>ASSISTENZA INFERMIERISTICA<br/>AL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE<br/>NON TRAUMATICO</b> | <b>P.O. 04</b><br><br>Rev. 0<br><br>Pag. 3 di 8 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## ***INDICE***

|           |                                                                                            |             |          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|
| <b>1.</b> | <b>PREMESSA .....</b>                                                                      | <b>pag.</b> | <b>4</b> |
| <b>2.</b> | <b>SCOPO E OBIETTIVI.....</b>                                                              | <b>pag.</b> | <b>4</b> |
| <b>3.</b> | <b>CAMPO DI APPLICAZIONE .....</b>                                                         | <b>pag.</b> | <b>4</b> |
| <b>4.</b> | <b>RESPONSABILITÀ .....</b>                                                                | <b>pag.</b> | <b>4</b> |
| <b>5.</b> | <b>DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATE .....</b>                                        | <b>pag.</b> | <b>5</b> |
| <b>6.</b> | <b>MODALITÀ OPERATIVE .....</b>                                                            | <b>pag.</b> | <b>5</b> |
|           | <b>6.1 Percorso assistenziale nel paziente affetto da dolore addominale non traumatico</b> | <b>pag.</b> | <b>5</b> |
|           | <i>6.1.1 Paziente con patologia subocclusivo-occlusiva .....</i>                           | <b>pag.</b> | <b>6</b> |
|           | <i>6.1.2 Paziente affetto da sindrome peritonitica .....</i>                               | <b>pag.</b> | <b>6</b> |
|           | <i>6.1.3 Paziente affetto da dolore epigastrico e/o quadranti superiori .....</i>          | <b>pag.</b> | <b>7</b> |
|           | <i>6.1.4 Paziente affetto da colica ureterale .....</i>                                    | <b>pag.</b> | <b>7</b> |
|           | <b>6.2 Dimissione o trasferimento .....</b>                                                | <b>pag.</b> | <b>7</b> |
|           | <b>6.2 Gestione della documentazione .....</b>                                             | <b>pag.</b> | <b>7</b> |
| <b>7.</b> | <b>MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ.....</b>                                    | <b>pag.</b> | <b>7</b> |
| <b>8.</b> | <b>RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI.....</b>                                          | <b>pag.</b> | <b>7</b> |

## **1. PREMESSA**

Si definisce Dolore Addominale non Traumatico una manifestazione dolorosa insorta acutamente, localizzata e/o riferita all'addome (ovvero in una zona del corpo delimitata in alto dal diaframma ed in basso dal piano pelvico) non correlabile ad evento traumatico.

Rappresenta uno dei sintomi più comuni e complessi affrontati dalle strutture di Emergenza –Urgenza (5-10% degli accessi in P.S.).

Le cause di dolore addominale possono essere imputabili a:

### Cause Intra-Addominali

- ☒ Ostruzione e perforazione del viscere
- ☒ Patologie vascolari
- ☒ Dolore infiammatorio acuto (dell'appendice, del pancreas, del peritoneo, generalizzata o localizzata)
- ☒ Dolore colico Ureterale, Biliare o da distensione capsulare

### Cause Extra-Addominali

- Patologie Toraciche (IMA, Polmoniti, Pleuriti, TEP, PNX, Patologie Esofagee)
- ☒ Compressione o Flogosi di radici o nervi spinali (Herpes Zoster, Tumori, Ematomi)
- ☒ Malattie metaboliche (Uremia, Porfiria, Febbre Reumatica, Ipotiroidismo)
- ☒ Malattie dell'apparato urogenitale
- ☒ Cause tossiche (Avvelenamento da Pb )
- ☒ Cause psichiatriche

## **2. SCOPO E OBIETTIVI**

Il presente protocollo definisce le modalità operative e le responsabilità relative alla gestione infermieristica del dolore addominale non traumatico al fine di uniformare e omogeneizzare i comportamenti del personale sanitario (Infermiere, OSS).

In particolare gli obiettivi che si intendono raggiungere in un'ottica di multidisciplinarietà sono:

- Assicurare un intervento tempestivo
- Stabilizzazione precoce del paziente in fase acuta
- Diminuire le giornate di degenza

## **3. CAMPO DI APPLICAZIONE**

Il presente protocollo deve essere applicato dal personale infermieristico e dal personale di supporto addetto all'assistenza (OSS), in collaborazione con il personale medico dell'U.O. Medicina d'Urgenza ogniqualvolta vi è la necessità di assistere un paziente che presenta dolore addominale non traumatico.

## **4. RESPONSABILITÀ**

Le figure professionali coinvolte in questo protocollo sono:

- Infermiere
- Personale di supporto addetto all'assistenza

L'infermiere valuterà, in base alle singole situazioni ed alle condizioni psicofisiche del paziente, se avvalersi dell'opera del personale di supporto in autonomia o in collaborazione come recita l'art.1 del *Profilo Professionale dell'infermiere (D.M. 739/94)*.

**5. DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI UTILIZZATE**

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>C.V.</b>                         | catetere vescicole                                          |
| <b>D.T.</b>                         | dolore toracico                                             |
| <b>E.R.:</b>                        | esplorazione rettale                                        |
| <b>ECG</b>                          | Elettrocardiogramma                                         |
| <b>enzimi di necrosi miocardica</b> | prelievo ematico del dosaggio di troponina mioglobina ck-mb |
| <b>EV</b>                           | endovena                                                    |
| <b>F.C.</b>                         | frequenza cardiaca                                          |
| <b>IMA</b>                          | infarto miocardico acuto                                    |
| <b>Inf.</b>                         | infermiere                                                  |
| <b>M.U.</b>                         | medicina d’urgenza                                          |
| <b>Mdg</b>                          | medico di guardia                                           |
| <b>O<sub>2</sub></b>                | ossigeno                                                    |
| <b>OBI</b>                          | osservazione breve intensiva                                |
| <b>OS</b>                           | bocca                                                       |
| <b>OSS</b>                          | operatore socio sanitario                                   |
| <b>P.A.</b>                         | pressione arteriosa                                         |
| <b>P.S.</b>                         | Pronto soccorso                                             |
| <b>P.V.</b>                         | parametri vitali                                            |
| <b>PNX</b>                          | pneumotorace                                                |
| <b>Pz</b>                           | paziente                                                    |
| <b>RX</b>                           | radiografia                                                 |
| <b>Sat. O<sub>2</sub></b>           | saturazione dell’ossigeno                                   |
| <b>Sn</b>                           | sinistro                                                    |
| <b>SNG</b>                          | sondino nasogastrico                                        |
| <b>T.C.</b>                         | temperatura corporea                                        |
| <b>t<sup>0</sup></b>                | 1° prelievo tempo zero                                      |
| <b>t<sup>1</sup></b>                | 2° prelievo 6 ore dopo t0                                   |
| <b>t<sup>2</sup></b>                | 3° prelievo 12 ore dopo t0                                  |
| <b>TEP</b>                          | trombo embolia polmonare                                    |

**6. MODALITÀ OPERATIVE**

Il paziente può essere inviato dal PS in Medicina d’Urgenza, previ accordi telefonici con il medico di reparto, secondo due diverse finalità:

1. **O.B.I.:** osservazione breve di condizioni cliniche per le quali è prevedibile una conclusione dell’iter diagnostico e/o del primo trattamento entro 24 ore
2. **M.U.:** ricovero per inquadramento e trattamento di condizioni cliniche per cui si prevede un tempo di degenza di 2/3 giorni

**Responsabile:** infermiere

**6.1 PERCORSO ASSISTENZIALE NEL PAZIENTE AFFETTO DA DOLORE ADDOMINALE  
NON TRAUMATICO**

L’infermiere in collaborazione con il personale di supporto, per tutti i pazienti che presentano dolore addominale non traumatico, deve mettere in atto le seguenti azioni:

|                                                                              |                                                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Az. Osp. – Univ.<br/>Pisana</b><br><br><b>U.O. Medicina<br/>d’Urgenza</b> | <b>ASSISTENZA INFERMIERISTICA<br/>AL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE<br/>NON TRAUMATICO</b> | <b>P.O. 04</b><br><br>Rev. 0<br><br>Pag. 6 di 8 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

- ✓ Accoglienza del Pz e suo posizionamento a letto ( Inf. e OSS)
- ✓ Diminuire lo stato d’ansia del Pz attraverso il dialogo, fornendogli le informazioni inerenti i trattamenti a cui verrà sottoposto
- ✓ Informare il medico dell’arrivo in reparto del Pz
- ✓ Accertamento della presenza di uno o più accessi venosi di calibro adeguato ( almeno 18G )
- ✓ Monitoraggio PV ( SAT O<sub>2</sub>, FC, PA, TC, )
- ✓ Somministrazione terapia secondo prescrizione medica
- ✓ Misurazione e monitoraggio del dolore vedi P.A.32 **“Misurazione, valutazione, registrazione e monitoraggio del dolore”**

**Dal momento in cui viene diagnosticata la patologia che determina il dolore addominale non traumatico, l’infermiere seguirà uno dei seguenti schemi definiti:**

#### *6.1.1 Paziente con patologia subocclusivo-occlusiva*

L’infermiere in collaborazione con il personale sanitario di supporto provvede a:

- ☞ Posizionare SNG (vedi I.O 07 )
- ☞ Valutare ristagno gastro enterico (qualità, quantità)
- ☞ Posizionare CV (vedi I.O. 03 )
- ☞ Monitoraggio diuresi oraria >50ml
- ☞ Idratare EV
- ☞ Controllo del dolore (vedi P.A.32)
- ☞ Prelievo ematico ogni 12-24 ore (Emocromo, creatinina, elettroliti, glicemia)
- ☞ Mantenere il paziente digiuno
- ☞ Effettuare clisteri evacuativi (vedi I.O. 04 )
- ☞ Preparare il paziente ad esami endoscopici-radiologici (colonscopia, clisma opaco) (I.O. 05 )

#### *6.1.2 Paziente affetto da sindrome peritonitica*

L’infermiere in collaborazione con il personale sanitario di supporto provvede a:

- ☞ Prelievo Ematico a 12-24 ore (Emocromo, Creatinina, Elettroliti, Glicemia, LDH, Acido lattico, Amilasi, ALT)
- ☞ Monitoraggio clinico
- ☞ Idratare EV
- ☞ Mantenere il paziente digiuno
- ☞ Controllo del dolore (P.A.32)
- ☞ Posizionare C.V. (vedi I.O.03)
- ☞ Monitoraggio della diuresi oraria > 50 ml con C.V. (vedi I.O. 03)

|                                                                              |                                                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Az. Osp. – Univ.<br/>Pisana</b><br><br><b>U.O. Medicina<br/>d’Urgenza</b> | <b>ASSISTENZA INFERMIERISTICA<br/>AL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE<br/>NON TRAUMATICO</b> | <b>P.O. 04</b><br><br>Rev. 0<br><br>Pag. 7 di 8 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

### 6.1.3 Paziente affetto da dolore epigastrico e/o quadranti superiori

L’infermiere in collaborazione con il personale sanitario di supporto provvede a:

|   |                                                                                                                          |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ☞ | Prelievo ematico a 12-24 ore (emocromo, creatinina, elettroliti, glicemia, LDH, acido lattico, amilasi, ALT, Bilirubina) |
| ☞ | ECG a 6-12 ore (vedi I.O.01)                                                                                             |
| ☞ | Prelievo per enzimi di necrosi miocardica a 6-12 ore                                                                     |
| ☞ | Controllo del dolore (vedi P.A. 32)                                                                                      |
| ☞ | Idratare EV                                                                                                              |
| ☞ | Mantenere il paziente digiuno                                                                                            |

### 6.1.4 Paziente affetto da colica ureterale

L’infermiere in collaborazione con il personale sanitario di supporto provvede a:

|   |                                        |
|---|----------------------------------------|
| ☞ | Controllo dolore (vedi P.A. 32)        |
| ☞ | Controllo diuresi (quantità e qualità) |
| ☞ | Controllo del vomito                   |
| ☞ | Idratare EV                            |

## 6.2 DIMISSIONE O TRASFERIMENTO

Al termine della valutazione, degli accertamenti e del trattamento, il medico dispone:

- ∅ Dimissione all’attenzione del medico curante con documentazione allegata ( *Consegnare tutta la documentazione personale al paziente o ai familiari* )
- ∅ Trasferimento ad altra UO (vedi IO 02)

## 6.3 GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

**Responsabile: infermiere**

### ∅ *Al momento dell’accettazione provvede a :*

- Intestare la cartella clinica con inserimento dei dati anagrafici (è indispensabile riportare nella cartella clinica uno o più recapiti telefonici di persone di riferimento per il paziente; nel caso in cui siano già indicati nel *verbale di Pronto Soccorso* verificarne l’esattezza)
- Raccogliere ed inserire in cartella clinica il *verbale di Pronto Soccorso* e i referti degli esami effettuati in P.S. (immagini radiografiche e relativi referti, ECG, esami ematochimici, consulenze specialistiche)
- Raccogliere ed inserire in cartella clinica eventuale materiale relativo a ricoveri precedenti
- Compilare la *scheda infermieristica* (NB: L’infermiere è responsabile della compilazione della scheda infermieristica e della raccolta delle notizie anamnestiche di interesse infermieristico)
- Registrare i dati anagrafici del paziente negli appositi registri (*Registro M.U., Registro O.B.I., Rubrica Ricoveri e Registro movimento*)
- Consegnare l’*Opuscolo informativo* specifico dell’U.O.

### ∅ *al momento della dimissione*

*Togliere la cartella dall’inserito e porla nel contenitore dedicato ai fini dell’archiviazione di cui è responsabile il collaboratore amministrativo*

|                                                                              |                                                                                            |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Az. Osp. – Univ.<br/>Pisana</b><br><br><b>U.O. Medicina<br/>d’Urgenza</b> | <b>ASSISTENZA INFERMIERISTICA<br/>AL PAZIENTE CON DOLORE ADDOMINALE<br/>NON TRAUMATICO</b> | <b>P.O. 04</b><br><br>Rev. 0<br><br>Pag. 8 di 8 |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|

## 7. MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E SUA PERIODICITÀ

L’aggiornamento del presente protocollo è consequenziale al mutamento delle norme nazionali, regionali, aziendali o etico-professionali o in occasione di mutamenti di indirizzo proposti da norme, regolamenti ed indicazioni tecniche degli organismi scientifici nazionali ed internazionali.

## 8. RIFERIMENTI NORMATIVI E BIBLIOGRAFICI

|   |                                                                                                                                                                  |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ➤ | <i>Medicina d’urgenza per l’infermiere</i> – a cura di Mario Marzaloni- Maggioli editore                                                                         |
| ➤ | <i>Manuale di Medicina d’emergenza</i> – a cura di Della Corte, Olliveri, Enrichens, McGraw-Hill                                                                 |
| ➤ | <i>Procedure infermieristiche cliniche</i> (Pritchard-Mallet) 3a edizione Edizione italiana a cura di Julita Sansoni-McGraw-Hill Libri Italia, S.r.l. Milano     |
| ➤ | <a href="http://www.simeu.it">www.simeu.it</a>                                                                                                                   |
| ➤ | Decreto ministeriale 14 settembre 1994, n.739, <i>Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’infermiere</i> |
| ➤ | Legge 26 febbraio 1992, n.42, <i>Disposizioni in materia di professioni sanitarie</i>                                                                            |